SDD 160 Sujet n°1

Spécialité : Pédiatrie / Pneumologie

Date : 03/11/2023
Auteur : Marie-Lise PAJCZER (DES de pédiatrie - ECN 2023)
Relecteur(s) : Sébastien VILLARD (DES de médecine interne - ECN 2023), Lukas WIDMANN (DES de Pédiatrie - ECN 2020)

Domaine d'apprentissage principal	Interrogatoire
Domaine d'apprentissage secondaire	Stratégie de prise en charge
Item(s) en lien avec la station	359 - Détresse et insuffisance respiratoire aigüe du nourrisson, de l'enfant et de l'adulte
Situation(s) de départ en lien avec la station	160 – Détresse respiratoire aigüe
Matériel nécessaire à la station	Tablette pour présentation vidéo
Contexte de la station	Bronchiolite

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :

Vous êtes interne de pédiatrie. Nous sommes en novembre, vous venez de commencer votre semestre aux urgences pédiatriques. Votre chef vous demande de prendre en charge la petite Lilou, 7 semaines, accompagnée par sa maman.
Avant que vous rentriez dans le box, vous jetez un coup d'œil aux informations recueillies par l'infirmière d'accueil et d'orientation (IAO)

Lilou, 7 semaines
Gène respiratoire depuis 48h. Apyrétique.
FC 170, SpO2 92% en air ambiant, FR en cours

Vous entrez dans le box.

Consignes :

En 7 minutes, vous devez :

- Interroger la mère et expliquer les éventuels signes de gravité que vous repérez dans le discours de la maman
- Exploiter la vidéo présentée
- Poser un diagnostic en expliquant brièvement de quoi il s'agit à la mère
- Proposer des éléments de prise en charge

Vous ne devez pas :

- Faire un examen clinique de Lilou
- Rédiger une ordonnance

Attention : Vous avez 7 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA
GRILLE D'EVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques (max 15 items)			
1.	Recherche les symptômes positifs de bronchiolite (au moins 2 symptômes parmi les 3) - **Premier** épisode aigu de **gêne respiratoire** - Apparition initiale d'une **rhinite** - Puis d'une **toux**	1 pt	☐
2.	identifie les signes de lutte sur la vidéo	1 pt	☐
3.	Demande la fréquence respiratoire	1 pt	☐
4.	Recherche une diminution des apports alimentaires < 50% des rations habituelles	1 pt	☐
5.	Recherche une perte de poids	1 pt	☐
6.	Recherche la présence d'épisodes antérieurs	1 pt	☐
7.	Recherche la notion de terrain à risque (au moins 2 parmi) - Prématurité - Déficit immunitaire, ventilation néonatale prolongée, T21, maladie neuromusculaire, cardiopathie congénitale - Pathologie chronique - Contexte social défavorable - Tabagisme passif	1 pt	☐
8.	Élimine les diagnostics différentiels (2 parmi tous) - Présence de fièvre à la maison ? - éventuels antécédents cardiologiques ? - mauvaise prise pondérale - stridor - toux chronique préalable	1 pt	☐
9.	Aborde spontanément le diagnostic de bronchiolite	1pt	☐
10.	Identifie qu'il s'agit d'une bronchiolite de sévérité modérée	1pt	☐
11.	Propose un fractionnement des repas	1pt	☐

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

12	Propose une désobstruction rhino-pharyngée	1pt	☐
13.	Ne propose pas de mettre des antibiotiques au vu de la probable étiologie virale	1 pt	☐
14.	Ne demande pas de radiographie ou de bilan sanguin	1 pt	☐

Communications et attitudes (ICI) (max 5 grilles)

1. APTITUDE À ÉCOUTER : le patient / le pair

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Interrompt le patient /pair de façon inappropriée Ignore les réponses du patient/collègue	Se montre impatient	Est attentif aux réponses du patient/pair	Est attentif aux réponses du patient/pair Adopte la technique de reformulation si l'information est imprécise ou éloignée des objectifs.	Porte une attention soutenue aux réponses du patient/pair et à ses préoccupations.

2. APTITUDE À QUESTIONNER

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Pose des questions fermées ou trop directives ou qui ne répondent pas aux objectifs Utilise le jargon médical	Pose des questions qui s'éloignent des objectifs Utilise quelques fois un jargon médical sans explication	Utilise différents types de questions couvrant les éléments essentiels Utilise quelques fois un jargon médical mais toujours avec explications	Pose des questions précises couvrant la plupart des éléments avec quelques omissions mineures Utilise le langage approprié	Pose les questions avec assurance et savoir-faire

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

4. APTITUDE À STRUCTURER/ MENER L'ENTREVUE

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Approche désordonnée	Entrevue peu structurée, présente les difficultés à recadrer les discussions qui s'éloignent des objectifs	Entrevue centrée sur le problème et couvre les éléments essentiels	Entrevue menée de façon logique, structurée, centrée sur le problème, ne cherche pas l'information non pertinente	Entrevue ayant un but précis, approche intégrée

8. APTITUDE À FAIRE LA SYNTHÈSE DES DONNÉES

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
N'arrive pas à faire ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème quelquefois sans les justifier	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Fait ressortir les éléments positifs et négatifs pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Agit avec assurance et sans erreur

12. APTITUDE À PROPOSER UNE PRISE EN CHARGE (situations aiguës / chroniques)

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Est incapable de proposer une prise charge adaptée à la situation clinique	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels, n'arrive pas à justifier la démarche	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels et justifie la démarche.	Propose une prise pertinente. Ne s'attarde pas au traitement/prise en charge inutile et justifie la démarche.	Etablit l'ordre de priorité des différents aspects de la prise en charge du patient (hiérarchise).

TOTAL	19 points

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA

SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Vous êtes interne de pédiatrie. Nous sommes en novembre, vous venez de commencer votre semestre aux urgences pédiatriques. Votre chef vous demande de prendre en charge la petite Lilou, 7 semaines, accompagnée par sa maman. Avant que vous rentriez dans le box, vous jetez un coup d'œil aux informations recueillies par l'infirmière d'accueil et d'orientation (IAO)

Lilou, 7 semaines
Gène respiratoire depuis 48h. Apyrétique.
FC 170, SpO2 92%, FR en cours

Vous entrez dans le box.

Plan de la station ECOS :

Box avec un bureau.

<u>Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :</u>

« Bonjour docteur. Je suis la maman de Lilou, je suis très inquiète parce que depuis 2 jours, Lilou à des difficultés à respirer. Regardez, je l'ai même filmé tellement c'était impressionnant ! »

Identité du patient :

Lilou, fille, 7 semaines
6,300 kg, dernier poids 6,450 kg à la PMI la semaine dernière
57 cm

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

Mode de vie :

Gardée en crèche depuis une semaine, la maman vient de reprendre le travail après le congé maternité.
Un grand frère de 3 ans qui est rentré en maternelle en septembre.
Père étayant
Pas de tabagisme à la maison.
Pas d'allergies connues

Comportement global :

Maman anxieuse

Antécédents personnels :

Née à terme, accouchement voie basse sans complication, pas de facteur de risque d'infection néonatale bactérienne précoce.
Retour à la maison à J3, reprise du poids de naissance à J10

Aucun antécédent notable dont pas de déficit immunitaire, ventilation néonatale prolongée, T21, maladie neuromusculaire, cardiopathie congénitale

Antécédents familiaux :

Asthme chez le papa
Eczéma chez la maman

Médicaments :

Vitamine D 3 gouttes par jour

Symptômes positifs :

Rhinite et toux depuis 3 jours
Respire vite depuis ce matin
Pas de température mesurée à la maison

Si l'étudiant demande le poids -> « Lilou a perdu 250g par rapport à la consultation à la PMI la semaine dernière »

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

Si l'étudiant demande si l'enfant mange bien -> « oh non docteur et ça m'inquiète beaucoup »
Si l'étudiant demande quelle quantité Lilou mange « elle a bu à peine la moitié de ses biberons depuis cette nuit. »

Si l'étudiant demande s'il y a d'autres personnes malades dans l'entourage -> « son grand frère a le nez qui coule depuis une semaine »

Pas de mauvaise prise pondérale. Pas de stridor. Pas de toux chronique préalable.

Constantes :

FR65/min. SpO2 92%
FC 170 bpm
TA non mesurée

Donnée complémentaire :

Vidéo de l'enfant le matin même de la venue aux urgences
https://www.youtube.com/watch?v=sPxPYZbQ5UY
A présenter à l'étudiant dès le début de la prise en charge

Questions de relance :

Si à 4 minutes, l'étudiant n'a pas abordé le sujet de la bronchiolite
- Lui dire : « j'ai une copine dont le fils a eu un truc qui s'appelle bronchiolite, est ce que vous pensez que ça pourrait être ça docteur ? »

Si à 5 minutes, l'étudiant n'a pas abordé la notion de gravité
- Le questionner « mais vous pensez que c'est grave ça docteur ? qu'est ce qu'on va faire pour Lilou ? »

Demande systématiquement à 6 min s'il est nécessaire de faire une prise de sang, une radiologie et de donner des antibiotiques

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)